

Tema 3: Neuropsiquiatría del mayor: demencia; depresión; temblor.

1. Introducción y relevancia clínica

Los trastornos neuropsiquiátricos son altamente prevalentes en personas mayores y representan una causa significativa de **discapacidad**, **dependencia** y **sobrecarga del cuidador**. Entre ellos destacan:

- **Demencia**: trastorno neurocognitivo mayor, progresivo, que afecta memoria, funcionalidad e independencia.
- **Depresión en la vejez**: frecuente y subdiagnosticada, puede simular deterioro cognitivo y aumenta riesgo de suicidio.
- **Temblor**: síntoma motor común que puede indicar trastorno neurológico, efecto farmacológico o cambio relacionado a la edad.

Estos cuadros comparten una característica clave:

afectan directamente la **autonomía funcional**, eje central de la geriatría.

En el **EUNACOM**, estos temas aparecen en contextos:

- Diagnóstico diferencial entre **demencia vs depresión**.
- Identificación de **delirium vs demencia**.
- Distinción entre **temblor esencial y Parkinson**.
- Elección de tratamientos seguros en personas mayores.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Demencia

Se define como un **deterioro cognitivo adquirido**, persistente y **progresivo**, que afecta una o más funciones cognitivas (memoria, lenguaje, praxias, funciones ejecutivas) y que **interfiere con la funcionalidad**.

Las causas más frecuentes:

Tipo	Características principales
Enfermedad de Alzheimer	Amnesia reciente precoz, atrofia hipocampal

Tipo	Características principales
Demencia vascular	Inicio más brusco, curso escalonado, relación con ACV
Demencia frontotemporal	Cambios de conducta, desinhibición, lenguaje afectado
Demencia con cuerpos de Lewy	Alucinaciones visuales, fluctuaciones cognitivas, parkinsonismo

La fisiopatología depende del tipo:

- Alzheimer: depósitos de **beta-amiloide** y **tau** → muerte neuronal.
- Vascular: daño isquémico crónico.
- Lewy: acumulación de **alfa-sinucleína**.
- Parkinson/demencia: depleción dopaminérgica nigro-estriatal.

Depresión en la persona mayor

No es parte del envejecimiento normal.

Se relaciona con:

- Aislamiento,
- Enfermedades crónicas,
- Pérdida funcional,
- Duelo,
- Dolor crónico.

Puede presentarse como:

- **Tristeza atenuada**, irritabilidad, lentitud psicomotora,
- **Pérdida de interés** más que llanto,
- **Quejas somáticas** (insomnio, dolor).

Importante: la depresión puede simular demencia (**pseudodemencia depresiva**).

Temblor

Es un **movimiento rítmico e involuntario** de una parte del cuerpo.

Clasificación clave:

Tipo de temblor	Se observa en...	Causa probable
De reposo	en reposo, disminuye con movimiento	Parkinson
De acción / postural	al mantener postura o mover	Temblor esencial
Intencional	aumenta al acercarse a objetivo	Lesión cerebello

3. Clínica y diagnóstico diferencial

Demencia

Se caracteriza por:

- **Memoria reciente alterada,**
- Dificultad para realizar actividades habituales (manejo de cuentas, cocina, manejo de medicamentos),
- Desorientación temporal/espacial,
- Alteraciones del lenguaje,
- Cambios conductuales (apatía, irritabilidad).

Deterioro cognitivo leve (DCL)

Existe déficit cognitivo, **pero no pérdida funcional** significativa.

Diagnóstico diferencial clave:

Condición	Inicio	Curso	Atención	Reversibilidad
Demencia	Insidioso	Progresivo	Levemente alterada	No
Delirium	Agudo	Fluctuante	Marcadamente alterada	Sí, si se trata la causa
Depresión	Subagudo	Puede simular deterioro	Conservada: el paciente suele quejarse	Sí

Depresión

Signos clave en mayores:

- Pérdida de interés en actividades previas.
- Fatiga marcada.
- Dolor persistente sin causa clara.
- Insomnio o hipersomnia.
- Disminución del apetito.
- Expresión: “no vale la pena”, “estoy cansado de vivir”.

Pseudodemencia depresiva:

- El paciente se **queja activamente de pérdida de memoria**,
- Responde “no sé”,
- Inicio claro, rápido, relacionado con estrés o duelo,
- **Mejora con tratamiento antidepresivo.**

Temblor

Comparación clínica esencial:

Característica	Parkinson	Temblor esencial
Momento	Reposo	Acción / mantener postura
Simetría	Asimétrico al inicio	Habitualmente bilateral
Otros signos	Bradicinesia, rigidez	Solo temblor, sin rigidez
Respuesta al alcohol	No mejora	Puede mejorar
Tratamiento	Levodopa	Propranolol / primidona

4. Exámenes complementarios

Demencia

- Mini-Mental State Examination (MMSE) o MoCA,
- Test del reloj,
- Lawton-Brody para funcionalidad,
- TSH, vitamina B12, glicemia, electrolitos, función hepática,
- TAC o RM cerebral si inicio atípico o déficit focal.

Depresión

- GDS (Escala de Depresión Geriátrica),
- Evaluar hipotiroidismo, anemia, dolor crónico.

Temblor

- Clínico en la mayoría,
 - RM si sospecha lesión cerebelosa,
 - Revisión exhaustiva de fármacos (valproato, litio, antidepresivos pueden causarlo).
-

5. Tratamiento (MINSAL 2019)

Demencia

- Educación del cuidador y adaptación del entorno.
- Rutinas estructuradas.
- Rehabilitación cognitiva y estimulación social.

Fármacos (cuando indicado):

Tipo de demencia	Fármaco
Alzheimer leve–moderada	Donepezilo, rivastigmina, galantamina
Alzheimer moderada–avanzada	Memantina
Cuerpos de Lewy / Parkinson	Rivastigmina preferida

Evitar benzodiacepinas y anticolinérgicos → empeoran cognición.

Depresión

- Psicoterapia + ejercicio físico estructurado.
- Si farmacológico → preferir **ISRS (sertralina, escitalopram)**.
- Evitar paroxetina (efecto anticolinérgico).
- Si síntomas físicos intensos → duloxetine (también para dolor).

Temblor

- **Temblor esencial:** propranolol o primidona.
- **Parkinsoniano:** levodopa/carbidopa.
- Evitar **haloperidol y antipsicóticos típicos** → empeoran parkinsonismo.

6. Complicaciones y pronóstico

Condición	Evolución	Riesgo principal
Demencia	Progresiva y crónica	Dependencia total, institucionalización
Depresión	Recurrente, tratable	Suicidio, deterioro funcional
Temblor	Variable según causa	Aislamiento social, discapacidad fina

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas

- **Demencia = deterioro cognitivo + pérdida funcional** (si no hay pérdida funcional, no es demencia).
- **Depresión puede simular demencia**; siempre tratar primero si hay sospecha.
- En Parkinson, el **primer síntoma motor suele ser bradicinesia**, no temblor.
- Nunca usar antipsicóticos típicos en demencia con cuerpos de Lewy → riesgo de **síndrome neuroléptico fatal**.

Errores comunes

- Iniciar donepezilo en deterioro cognitivo leve (no indicado).
- Usar clonazepam para ansiedad o insomnio en mayores (↑ caídas, delirium).
- Interpretar temblor esencial como Parkinson por no examinar postura y movimiento.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **demencia** implica deterioro cognitivo **y pérdida funcional**; diferenciarla de delirium y depresión.
 2. La **depresión en la vejez** puede ser silenciosa y debe pesquisarse activamente.
 3. La **pseudodemencia depresiva es reversible** si se trata adecuadamente.
 4. **Temblor esencial es de acción; Parkinson es de reposo + bradicinesia**.
 5. Evitar **benzodiacepinas y anticolinérgicos** en mayores siempre que sea posible.
 6. El manejo debe incluir **apoyo al cuidador y adaptación del entorno**.
 7. El objetivo final es **preservar la autonomía y calidad de vida**.
-